УГАДАЙ СНИМОК · МОДУЛЬ 4 ИЗ 4

Трубы и неотложные состояния

8 эхограмм. Посмотрите на снимок, прочитайте короткую вводную и выберите один из четырёх вариантов. Ответ и разбор — на следующем слайде.

01

На ответ — 30 секунд. Варианты называет вслух вся группа.

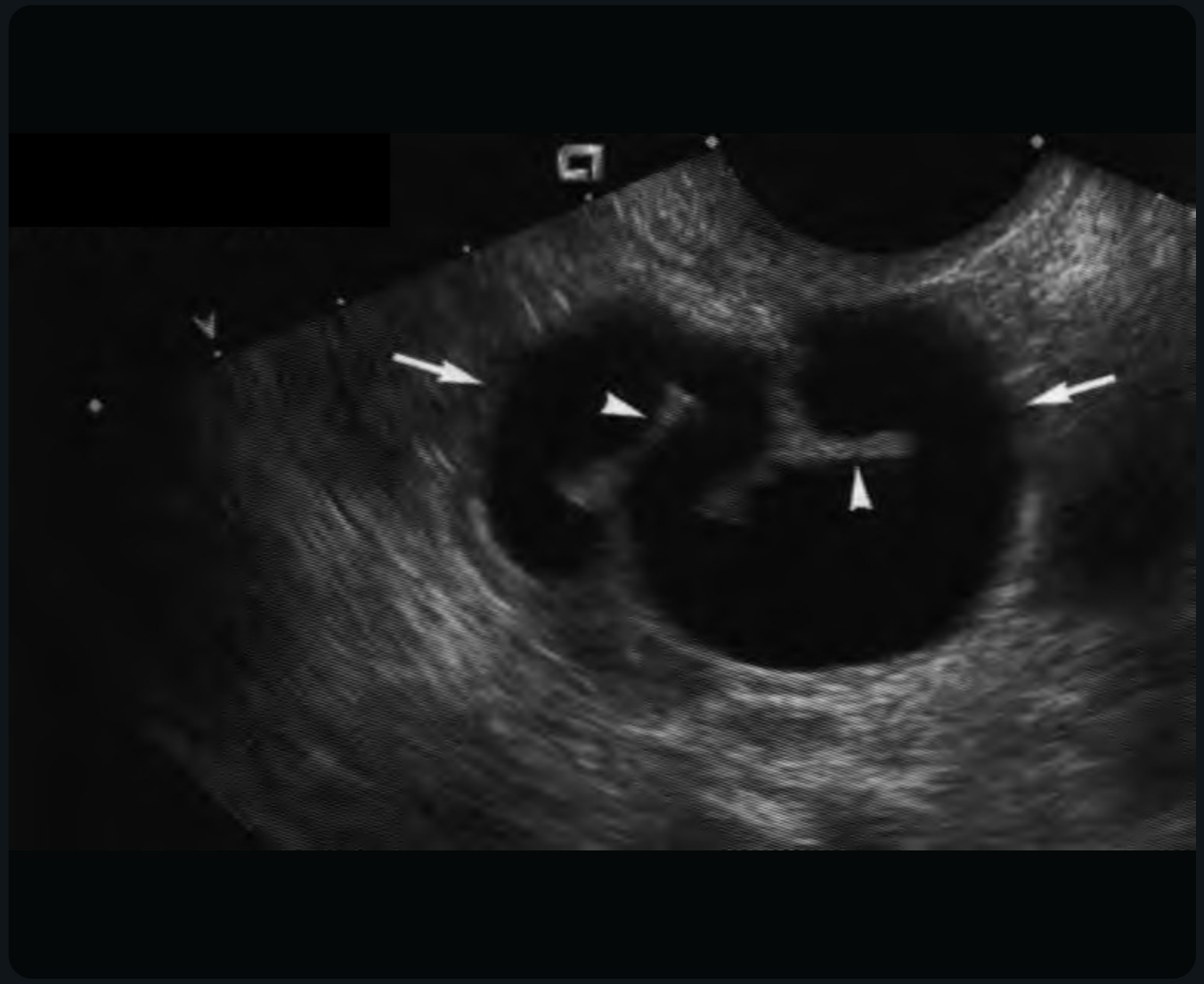
02

Назовите не только диагноз, но и признак, по которому вы его поставили.

03

Балл за верный ответ, ещё балл — за названный признак.

Жумагулов Н.М. · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош · Первичная специализация по УЗ-диагностике

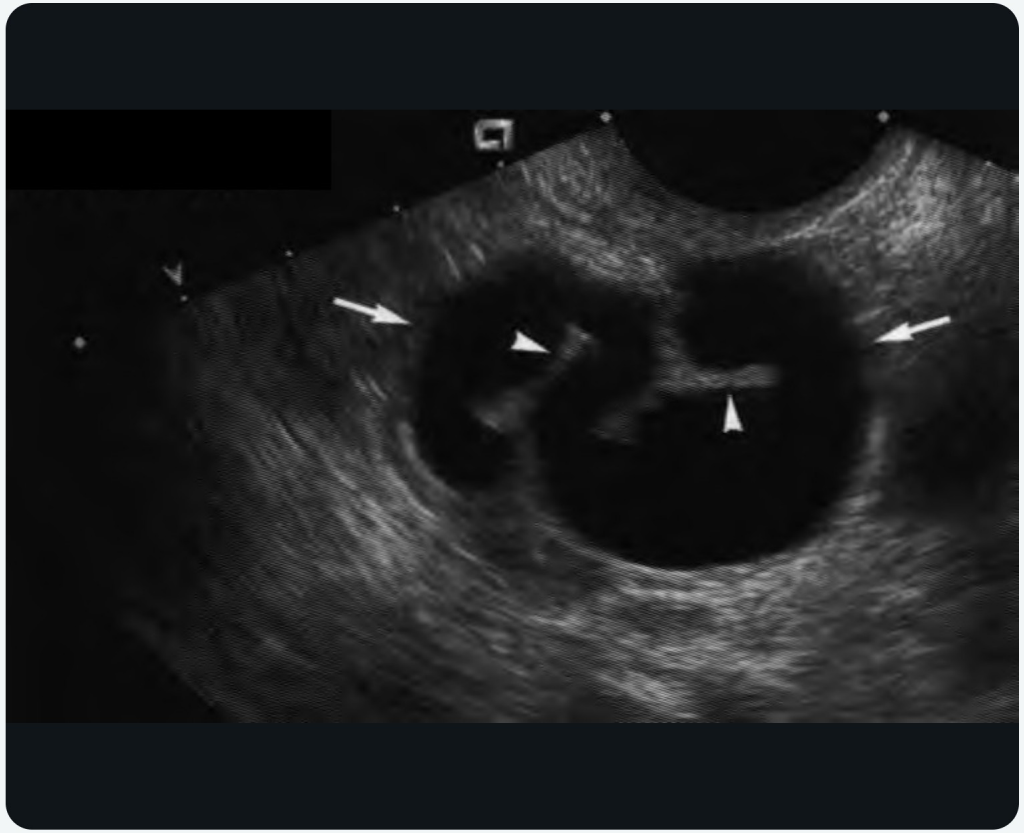


Снимок 1 / 8

ТВУЗИ, справа от матки, отдельно от яичника. Стрелки — контур, наконечники — внутренние структуры.

Ваше заключение?

- **А** Многокамерная киста яичника
- **Б** Параовариальная киста
- **В** Гидросальпинкс
- **Г** Расширенные вены малого таза



Ответ · B

Гидросальпинкс

- Продолговатая извитая кистозная структура отдельно от яичника.
- Неполные перегородки — складки слизистой трубы.
- Стенки тонкие, содержимое анэхогенное.

Вывод: неполная перегородка и извитая форма отличают трубу от многокамерной кисты яичника. Эхогенная взвесь в просвете — повод думать о пиосальпинксе.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 27.7-1



Снимок 2 / 8

ТВУЗИ, область придатков. Стрелки — контур образования; яичник отдельно не виден.

Ваше заключение?

- **А** Тубоовариальный абсцесс
- **Б** Эндометриома
- **В** Зрелая тератома
- **Г** Простой гидросальпинкс



Ответ · A

Тубооварриальный абсцесс

- Неоднородное многокамерное придатковое образование с нечёткими границами.
- В полостях — эхогенная жидкость (гной, частицы ткани), бывают толстые перегородки.
- Яичник окружён воспалительной тканью и отдельно не виден.

Вывод: УЗИ не всегда отличает абсцесс от другого сложного образования — диагноз ставят вместе с клиникой: лихорадка, тазовая боль, лейкоцитоз, резкая болезненность при давлении датчиком.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 27.8-1



Снимок 3 / 8

ХГЧ положительный. ТВУЗИ, левые придатки, образование вне яичника.

Ваше заключение?

А Желтое тело

Б Трубная беременность

В Параовариальная киста

Г Доминантный фолликул



Ответ · Б

Трубная беременность

- Внеяичниковое плодное яйцо с желточным мешком.
- Вокруг — толстое эхогенное кольцо трофобласта.
- Желточный мешок или эмбрион вне матки — специфичность 100%.

Вывод: достоверный признак виден лишь у 8–25% пациенток. Чаще находят только эхогенное кольцо (специфичность 95%) или неоднородное образование (86%).

Источник: Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности (2017), с. 70



Снимок 4 / 8

ХГЧ положительный. ТВУЗИ, придатки: О — яичник, стрелка — образование рядом с ним.

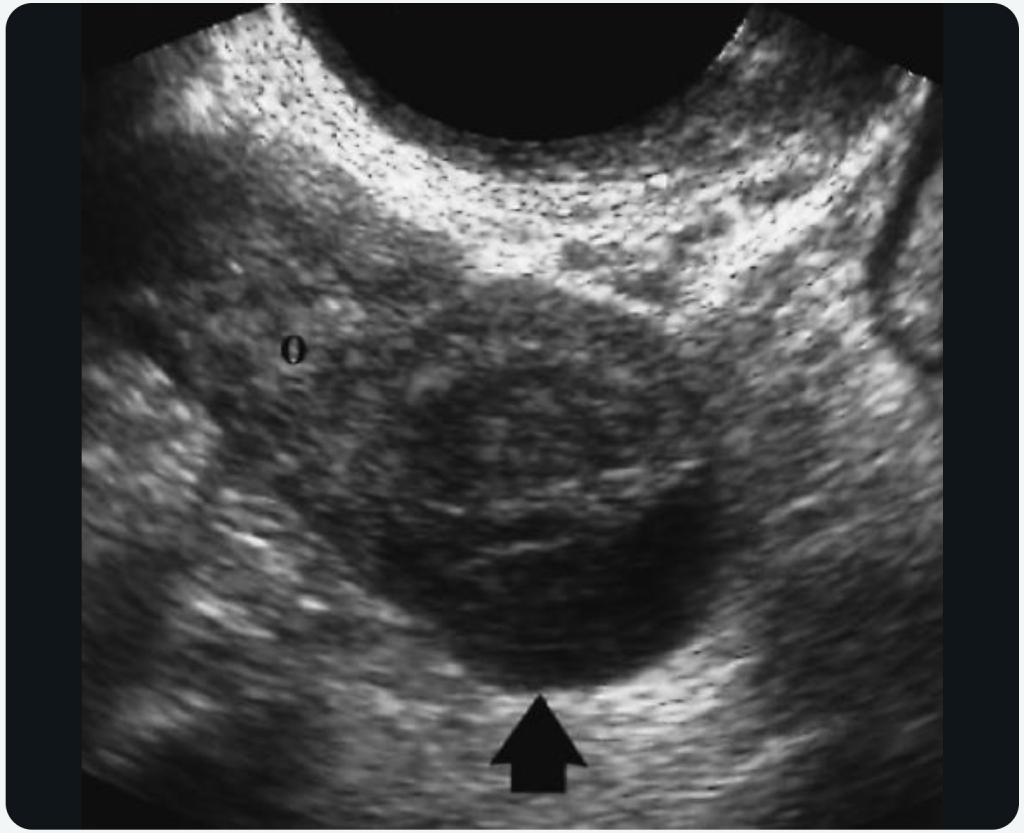
Ваше заключение?

А Геморрагическая киста желтого тела

Б Гематосальпинкс при трубной беременности

В Зрелая тератома

Г Петля кишки



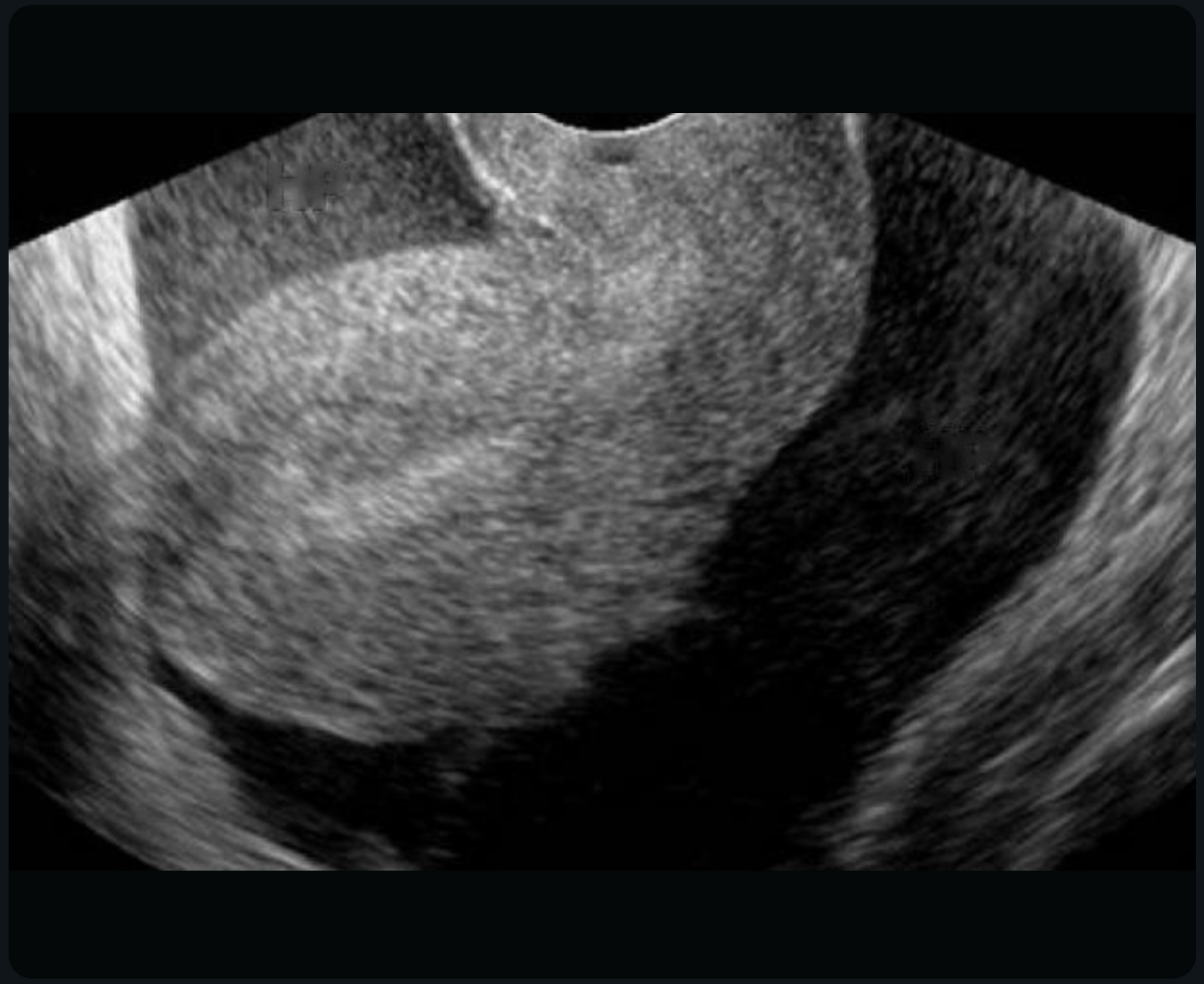
Ответ · Б

Гематосальпинкс при трубной беременности

- Эхогенное неоднородное образование вне яичника — кровь и сгустки в трубе.
- Мелкие анэхогенные зоны внутри — несвернувшаяся кровь.
- Сам признак — специфичность 86%; со свободной эхогенной жидкостью — 98%.

Вывод: надавите датчиком. Образование смещается отдельно от яичника — внеяичниковое; не отделяется — геморрагическое желтое тело.

Источник: Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности (2017), с. 82–86

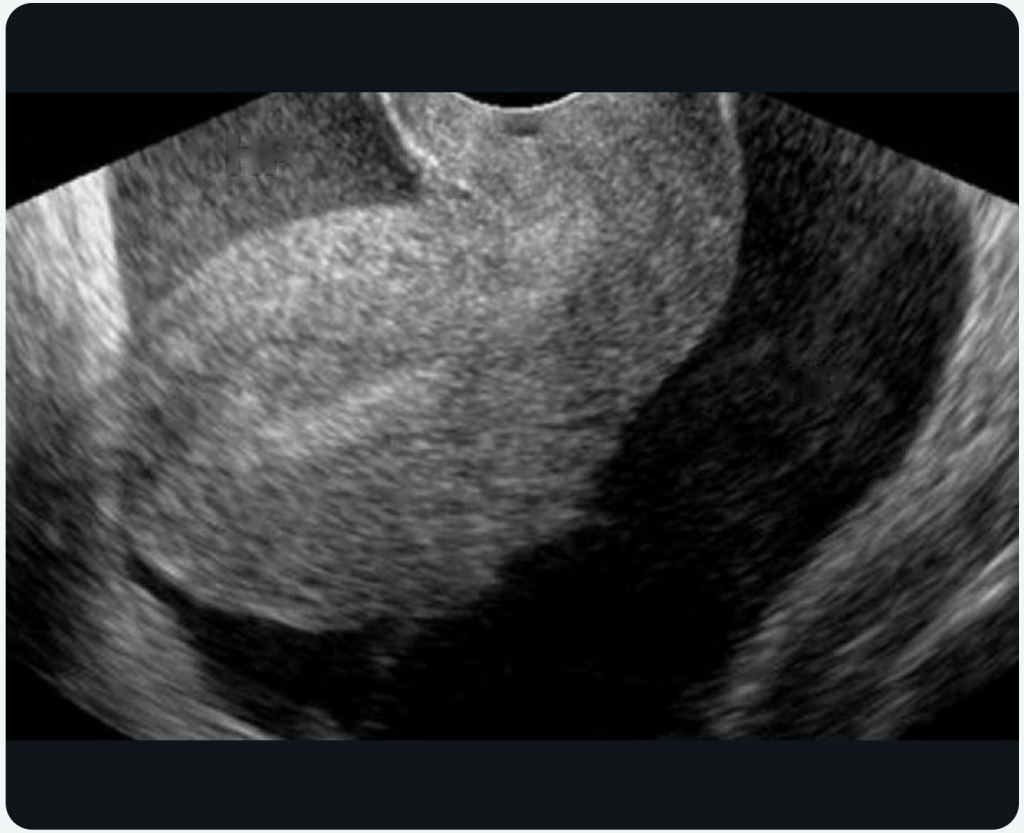


Снимок 5 / 8

ХГЧ положительный, острая боль в животе. ТВУЗИ, малый таз.

Ваше заключение?

- **А** Физиологическая жидкость в кармане Дугласа
- **Б** Гемоперитонеум
- **В** Асцит при гиперстимуляции
- **Г** Пиометра



Ответ · Б

Гемоперитонеум при разрыве трубной беременности

- Большое количество эхогенной жидкости окружает матку.
- Значимый гемоперитонеум — жидкость достигает дна матки или окружает её целиком.
- Сгустки вокруг трубного образования — косвенный признак разрыва.

Вывод: ТВУЗИ не оценивает объём кровопотери. Сразу проверьте карман Моррисона и спленоренальный карман (FAST): жидкость там — тяжёлый гемоперитонеум.

Источник: Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности (2017), с. 103



Снимок 6 / 8

ХГЧ положительный. ТВУЗИ, поперечный срез через дно матки.

Ваше заключение?

- **А** Маточная беременность в углу полости
- **Б** Интерстициальная беременность
- **В** Ампулярная трубная беременность
- **Г** Миома с кистозной дегенерацией



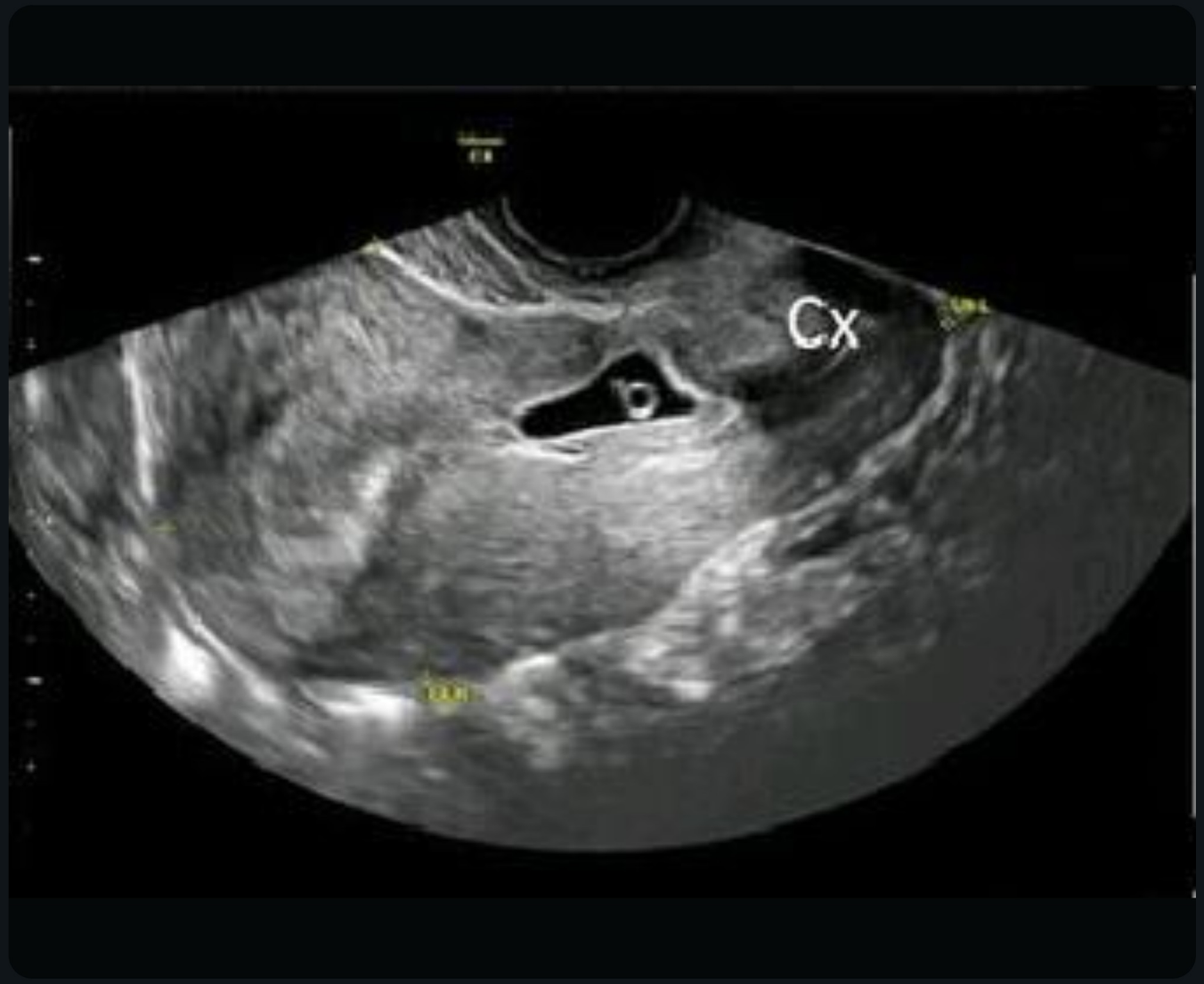
Ответ · Б

Интерстициальная беременность

- Плодное яйцо с толстыми эхогенными стенками лежит эксцентрично, вне полости.
- Миометрий вокруг асимметричный, по наружному краю угла местами отсутствует.
- При ЦДК — периферическое гиперваскулярное кольцо.

Вывод: при беременности в углу полости яйцо окружено миометрием со всех сторон и связано с эндометрием. Тонкий наружный миометрий — риск разрыва с массивным кровотечением.

Источник: Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности (2017), с. 111



Снимок 7 / 8

ХГЧ положительный. ТВУЗИ, сагиттальный срез матки; Cx — шейка матки.

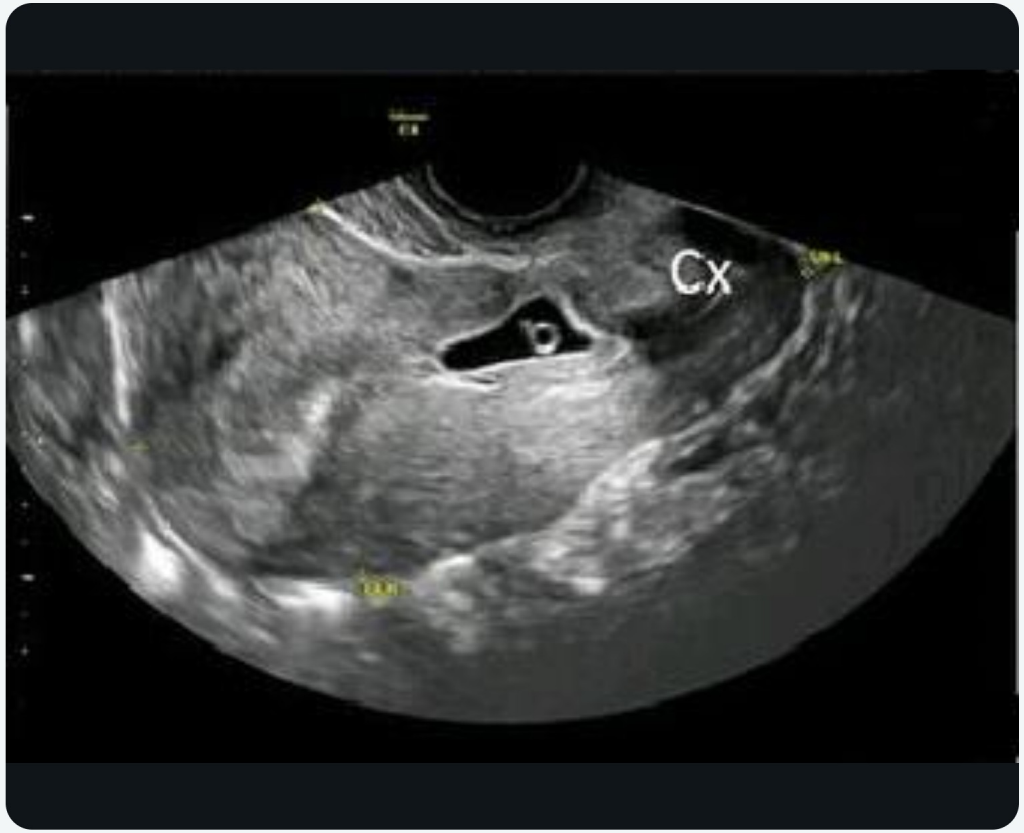
Ваше заключение?

А Шеечная беременность

Б Беременность в рубце после кесарева сечения

В Выкидыш в ходу

Г Низко расположенное плодное яйцо в полости



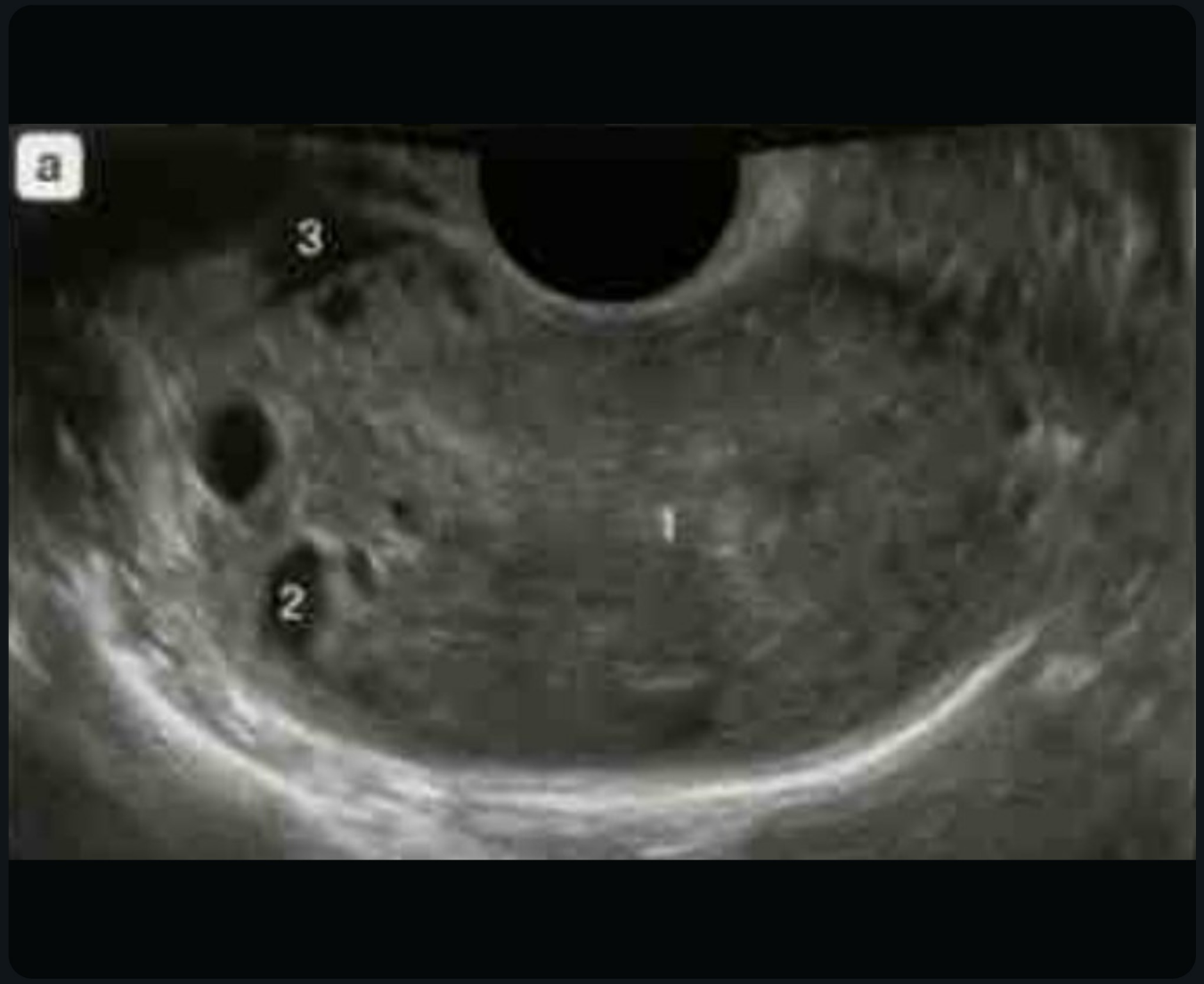
Ответ · Б

Беременность в рубце после кесарева сечения

- Плодное яйцо в передней стенке нижнего сегмента, над цервикальным каналом.
- Треугольная форма — яйцо заполняет нишу рубца (обычно до 7 недель).
- Миометрий кпереди от яйца истончён.

Вывод: ориентиры — шейка, мочевой пузырь и полость матки. Опишите остаточный миометрий перед яйцом: от этого зависит тактика.

Источник: Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности (2017), с. 121



Снимок 8 / 8

Девочка 12 лет, 3-и сутки от начала болевого приступа. Трансректально: яичник 6,2 × 3,4 × 3,8 см (42 см³).

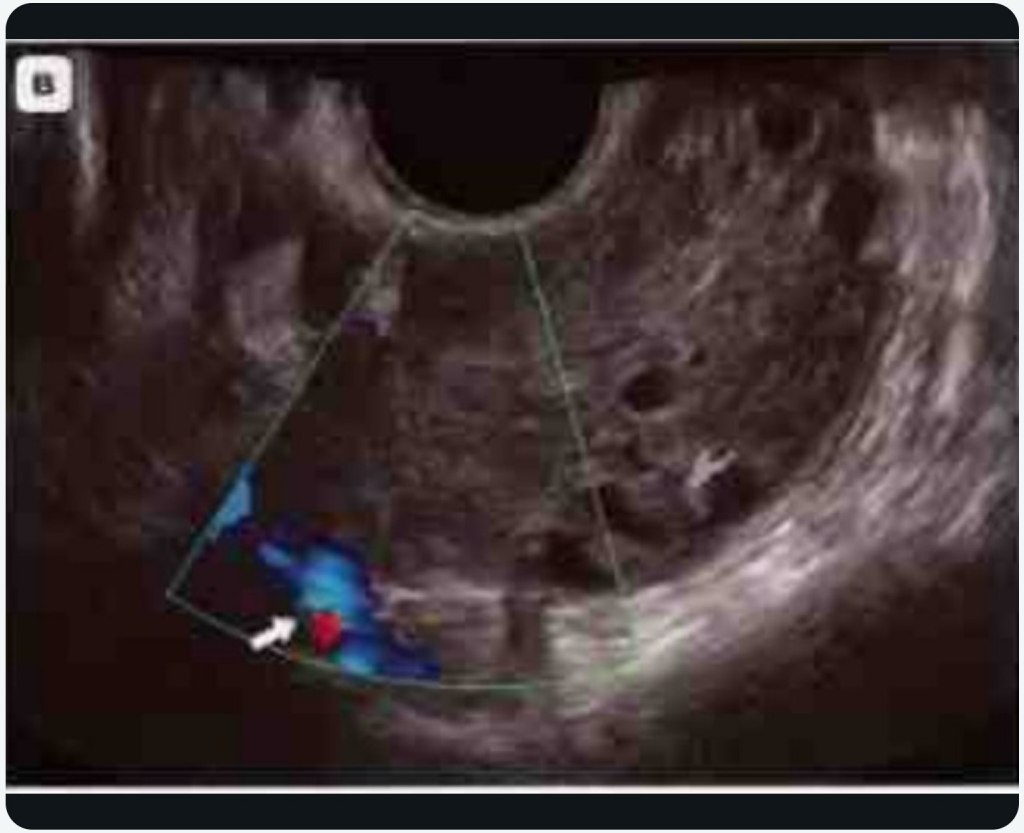
Ваше заключение?

А Мультифолликулярный яичник в пубертате

Б Перекрут яичника

В Апоплексия яичника

Г Дисгерминома



Ответ · Б

Перекрут яичника

- Яичник резко увеличен, строма неравномерно понижена (1), фолликулярного аппарата нет.
- Лишь по периферии — несколько антральных фолликулов (2); немного свободной жидкости (3).
- ЦДК (снимок слева): внутри яичника кровотока нет, в области ворот — только внеяичниковые сосуды.

Вывод: сохранённый кровоток перекрут не исключает — у яичника два источника кровоснабжения. Всегда сравнивайте с другим яичником.

Источник: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 3, рис. В.7

Ответы модуля 4

№	Диагноз	Ключевой признак
1	Гидросальпинкс	Извитая трубка с неполными перегородками
2	Тубоовариальный абсцесс	Неоднородное образование, нечёткие границы
3	Трубная беременность	Желточный мешок вне матки
4	Гематосальпинкс	Эхогенное образование отдельно от яичника
5	Гемоперитонеум	Эхогенная жидкость вокруг всей матки
6	Интерстициальная беременность	Яйцо вне полости, тонкий наружный миометрий
7	Беременность в рубце	Яйцо в нише над шейкой, миометрий истончён
8	Перекрут яичника	Большой отёчный яичник, фолликулы по краю

Эхограммы: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас (2011); Dr. Yuliya. Ургентная сонография при ранней беременности (2017); Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 3. Только для учебных занятий группы; для публикации нужно согласие правообладателей.